

Onicomycosis — Diagnóstico y tratamiento

(Basado en Guías Clínicas MINSAL Chile 2023, European Academy of Dermatology 2024 (EADV), American Academy of Dermatology 2024 (AAD), UpToDate 2025 y Fitzpatrick's Dermatology 2023.)

1. Introducción y relevancia clínica

La **onicomicosis** es una **infección fúngica de la uña**, causada principalmente por **dermatofitos**, aunque también pueden estar implicadas **levaduras** (*Candida* spp.) o **hongos no dermatofitos**.

Constituye alrededor del **50% de todas las enfermedades ungueales** y afecta más frecuentemente las uñas de los pies.

Aunque suele ser **benigna y crónica**, tiene impacto importante en la **calidad de vida**, genera **alteraciones estéticas, dolor, deformidad** y puede ser **puerta de entrada a infecciones bacterianas** (celulitis, erisipela), especialmente en pacientes **diabéticos o inmunodeprimidos**.

Relevancia clínica

- Muy frecuente en atención primaria y en adultos mayores.
 - Es causa común de consulta dermatológica y **pregunta recurrente en EUNACOM**.
 - Importante distinguirla de otras distrofias ungueales no micóticas.
 - El diagnóstico clínico no siempre basta: requiere **confirmación micológica** antes de iniciar tratamiento sistémico.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Patogenia

La infección se produce por **invasión del aparato ungueal (lámina, lecho o matriz)** por hongos queratinofílicos, que degradan la queratina a través de enzimas (queratinasas, proteasas).

El proceso puede originarse:

- Desde el **borde distal** (más común).
- Desde el **pliegue proximal** (en inmunodeprimidos).
- Desde la **superficie dorsal** o desde un **traumatismo previo**.

2.2. Agentes etiológicos principales

Grupo	Agente	Frecuencia / características
Dermatofitos	<i>Trichophyton rubrum</i> (más frecuente), <i>T. mentagrophytes</i> , <i>Epidermophyton floccosum</i>	70–90%
Levaduras	<i>Candida albicans</i> , <i>Candida parapsilosis</i>	Más frecuente en manos
Hongos no dermatofitos	<i>Scopulariopsis brevicaulis</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i>	Menos frecuente, difícil de tratar

2.3. Factores predisponentes

Categoría	Ejemplos
Locales	Traumatismos, humedad crónica, calzado oclusivo, uso de piscinas
Sistémicos	Diabetes mellitus, inmunosupresión, insuficiencia vascular periférica
Ambientales	Climas cálidos y húmedos
Otros	Edad avanzada, historia familiar, onicomicosis previa

2.4. Clasificación clínica (según vía de invasión)

Tipo	Características clínicas	Localización típica
Onicomycosis subungueal distal y lateral (OSDL)	Engrosamiento distal, coloración amarillenta, onicolisis progresiva	Uñas de pies
Onicomycosis subungueal proximal (OSPL)	Invasión desde el pliegue proximal, opacidad blanquecina en base de la uña	Inmunodeprimidos (VIH, trasplante)
Onicomycosis blanca superficial (OBS)	Manchas blancas opacas en superficie, friables	Uñas de pies, jóvenes
Onicomycosis distrófica total	Destrucción completa de la uña, resultado final de otras formas	Crónica
Onicomycosis candidiásica	Eritema, edema y paroniquia asociada	Uñas de manos, mujeres, lavadores

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Signos principales

- **Cambio de color:** blanco, amarillo, marrón o negro.
- **Engrosamiento** de la lámina ungueal.
- **Fragilidad y friabilidad** (la uña se quiebra fácilmente).
- **Onicolisis:** separación distal de la lámina del lecho.
- **Deformación o destrucción total** en casos avanzados.

- En *Candida*: paroniquia (inflamación periungueal) y dolor.
-

3.2. Uñas afectadas

- Predominio en **uñas de los pies (80–90%)**, sobre todo el **primer ortejo**.
 - En manos, más frecuente por ***Candida spp.***.
-

3.3. Síntomas asociados

- Sensación de presión o dolor con el calzado.
 - Mal olor (en casos de sobreinfección bacteriana).
 - Dificultad para cortar las uñas.
 - Impacto estético y psicológico.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Psoriasis ungueal	Piqueteado, manchas de aceite, no hay hongos en KOH
Liquen plano ungueal	Adelgazamiento, fisura longitudinal, pterigión
Traumatismo repetido	Hematoma subungueal, sin colonias fúngicas
Enfermedad vascular periférica	Distrofia por hipoxia crónica

Melanoma subungueal

Estría pigmentada, asimétrica, sin descamación

Eccema crónico / dermatitis

Onicosis y coloración sin engrosamiento marcado

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Confirmación micológica obligatoria

Antes de iniciar tratamiento sistémico, **se debe confirmar el diagnóstico**.

a)

Examen directo con KOH

- Toma: raspado de la lámina distal o fragmento del borde afectado.
- Se trata con hidróxido de potasio al 20% y se observa al microscopio.
- Permite visualizar **hifas o esporas**.
- Resultado rápido (en minutos).

b)

Cultivo micológico

- Medio Sabouraud con antibióticos.
- Identifica especie y descarta contaminación.
- Tarda 2–4 semanas.

c)

Biopsia ungueal con PAS

- En casos dudosos o negativos con alta sospecha.
- Permite visualizar hongos en el espesor de la uña.

4.2. Criterios diagn3sticos (seg3n EADV 2024)

El diagn3stico de certeza requiere **al menos uno de los siguientes**:

1. Hifas visibles en KOH.
2. Cultivo positivo para hongo pat3geno.
3. Tinci3n PAS o GMS positiva.

Nunca iniciar antif3ngicos sist3micos sin confirmaci3n micol3gica.

5. Tratamiento (seg3n gu3as MINSAL / EADV / AAD)

5.1. Objetivos

- Erradicar el hongo.
 - Restaurar la funci3n y est3tica de la uña.
 - Prevenir recurrencias y transmisi3n.
-

5.2. Consideraciones terap3uticas generales

- El tratamiento debe ser **prolongado (3–6 meses en manos, 6–12 meses en pies)**.
 - La adherencia es crucial.
 - Requiere higiene y corte adecuado de uñas, eliminaci3n de queratina residual y desinfecci3n de calzado.
-

5.3. Tratamiento t3pico (formas leves o <50% de la uña afectada)

F3rmaco

Dosis y duraci3n

Comentarios

Amorolfina 5% laca ungual	1–2 veces por semana por 6–12 meses	Buena penetración, uso prolongado
Ciclopirox 8% laca	Aplicación diaria, remover semanalmente	Más económico, útil en lesiones leves
Efinaconazol 10%	1 vez al día (uso reciente, alta eficacia)	Disponible en algunos países
Tioconazol / bifonazol tópicos	En paroniquia candidiásica leve	Adjuntivo

Indicadas solo si compromiso parcial (<50%) y sin afección de matriz.

5.4. Tratamiento sistémico (formas moderadas o severas)

Fármaco	Dosis habitual	Duración	Comentarios
Terbinafina	250 mg/día	6 sem (manos), 12 sem (pies)	Fármaco de elección; fungicida contra dermatofitos
Itraconazol	200 mg/día por 3 meses o 200 mg/12 h × 1 sem/mes × 3 meses	Alternativa; útil si <i>Candida</i> o hongo no dermatofito	
Fluconazol	150–300 mg/semana por 6–9 meses	Alternativa en intolerancia a otros	
Ketoconazol	No recomendado por hepatotoxicidad		

Antes de iniciar terapia oral, controlar **función hepática** (transaminasas).

No asociar terbinafina con fluconazol (sinergia no demostrada, aumenta hepatotoxicidad).

5.5. Tratamiento combinado

- **Tópico + sistémico:** mejora tasas de curación en infecciones extensas.
 - **Curetaje / limado mecánico:** útil como complemento.
-

5.6. Medidas generales y prevención

- Mantener **uñas cortas y secas**.
 - Evitar compartir cortaúñas o calzado.
 - Desinfectar zapatos con polvos antifúngicos.
 - Usar sandalias en piscinas o duchas públicas.
 - Controlar comorbilidades (diabetes, insuficiencia venosa).
-

5.7. Seguimiento

- Evaluar respuesta cada 3 meses.
 - Cultivo de control al finalizar tratamiento (confirmar curación).
 - Recaídas son frecuentes (10–30% a 2 años).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Recurrencia	Frecuente si persistente humedad o mal cumplimiento

Distrofia ungueal permanente En infecciones crónicas o tratamientos tardíos

Sobreinfección bacteriana Celulitis o erisipela (diabéticos)

Propagación a piel circundante Tiña pedis o manuum asociada

Hepatotoxicidad por antifúngicos Poco común, reversible

Pronóstico:

- Excelente con diagnóstico precoz y adherencia.
- Pies: respuesta más lenta y mayor recidiva.
- Requiere control y educación continua.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La **onicomicosis** es la causa más frecuente de distrofia ungueal.
2. **Confirmar siempre con KOH o cultivo antes de usar antifúngicos sistémicos.**
3. **Terbinafina** es el tratamiento de elección (fungicida contra dermatofitos).
4. En **Candida spp.** → preferir **itraconazol o fluconazol.**
5. Si el compromiso es parcial, **usar laca de amorolfina o ciclopirox.**
6. El tratamiento es **prolongado (meses)** y requiere **adherencia y medidas higiénicas.**

7. En **EUNACOM**, la clave es reconocer “uña engrosada, amarillenta, friable, confirmación con KOH positiva.”
-



Errores comunes

- Tratar empíricamente sin confirmación micológica.
 - Usar antibióticos tópicos o corticoides (sin efecto antifúngico).
 - Suspender tratamiento antes del tiempo recomendado.
 - Ignorar foco interdigital o plantar (tiña pedis asociada).
 - No controlar función hepática en terapias prolongadas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **onicomicosis** es una **infección fúngica de la uña**, causada principalmente por *Trichophyton rubrum*.
2. Se presenta con **engrosamiento, coloración amarilla y onicolisis**, predominando en uñas de los pies.
3. El **diagnóstico debe confirmarse con examen directo (KOH) o cultivo micológico** antes del tratamiento.
4. **Terbinafina oral** es el tratamiento de elección; **itraconazol o fluconazol** son alternativas.
5. En formas leves o superficiales, puede usarse **tratamiento tópico con amorolfina o ciclopirox**.
6. El tratamiento es **prolongado (3–6 meses en manos, 6–12 en pies)** y requiere control hepático.
7. En **EUNACOM**, recordar: “Engrosamiento amarillento de uñas de pies + KOH positivo = Onicomicosis”.

